

11주차

12절 자궁내막증식증 p.85

1. 개술

- ① 정의 : 자궁내막의 분비샘과 조직이 비정상적인 증식을 일으킨 것
- ② 특징
 - 비정상 자궁출혈을 유발
 - 자궁내막암으로 진행될 수 있는 전암단계로 간주 + 자궁내막암과 동시 발생 가능
 - 발병률 높아지는 추세 by PCOS, 비만인구 증가
- ③ 병리학적 분류 by 세포의 비정형성 여부, 샘관의 복잡성&밀집성
단순형 증식증 → 복합형 증식증 → 비정형성 증식증의 순서로 진행할수록 위중도 ↑
- ④ 증상 : 고농도의 **에스트로겐 파탄성 출혈** → 폭발적 출혈 발생
- ⑤ 예후: 좋지 않음, 유착의 재발이 잦으며 최악의 경우 자궁내막암이 유발됨.

※ASCUS “알아둬라”

- ASCUS: 비정형적 편평상피세포로 가장 흔한 이상소견
- 자궁경부의 표면을 형성하는 편평세포에 나타나는 이상소견
- 자궁경부암으로 진행될 가능성이 있으므로 주의해야 함.

2. 원인 및 위험인자

★★ 자궁내막증식증의 위험인자와 원인질환과 병리기전을 설명하시오 ‘12, 14

(P=프로게스테론, E=에스트로겐)

- ① 원인: **P에 의해 억제되지 않은 E의 지속적인 자궁내막 자극**
- ② 병기: 배란이 일어나지 않으면
 - E 분비 줄어들지 않고 계속되지만 P는 분비되지 않거나 적당한 양만큼 분비 X
 - E의 지속적인 자극으로 FSH 농도 감소되어 새로운 여포 발달되지 X
 - 파열되지 않은 여포가 점차 커져서 기능이 없는 낭성구조를 이룸
 - 이후 E이 감소하면 FSH가 증가하여 새로운 여포 발달함 (=PCOS)

결과적으로, 자궁내막은 estrogen의 지속적인 자극 하에 증식기가 지속되고 분비기
자궁 내막의 변화는 일어나지 않음. 이러한 현상이 지속되면 자궁내막증식증이 유발됨.
- ③ 폐경 후: 피하지방에서 생성된 과도한 E1의 자극이나 외인성으로 투여된 E에 의해 자궁내막증식증이 유발
- ④ 호르몬보충요법(=HRT)을 통한 E에 의한 자궁내막증식증 발생위험은 투여용량 & 투여기간에 비례하여 증가 (대체로 매 10년간 10배 증가)
- ⑤ **PCOS**는 가임기 배란장애의 가장 중요한 원인이자 자궁내막증식증의 주된 원인
- ⑥ **비만**도 주요 위험인자: 피하지방의 E 생성과 관련 O

3. 일반 증상

부정 출혈, 무월경 후의 월경과다

4. 진단

질식 초음파로 자궁내 비정상 증식으로 비후된 **자궁 두께**를 측정함

- 분비기 때 자궁내막 두께는 8-10mm인데, 이론적으로 16mm 이상이면 자궁내막 증식증이라고 진단. but 실제 임상에서는 20mm 이상일 때 자궁내막증식증의 소견이 있다고 판단함
- 한의사는 자궁내막증, 선근증 등 질환의 특징을 숙지하여 출혈 양상과 문진만으로도 질환을 알아볼 수 있어야 함.
- 자궁내막증식증은 복부 초음파보다는 질식 초음파로 봐야함. 단, 출혈이 있으면 관찰이 힘들기 때문에, 색류를 통해 지혈한 후 질식 초음파를 시행하는 경우가 많음.
- ★ 항상 **비정형성 증식증**을 염두에 두어야함. “젊은 사람도 비정형성 증식증의 가능성이 있다는 것을 반드시 염두하면서 진료에 임하시길 바랍니다”
→ 비정형성 세포 나오면 무조건 절제술 필수

5. 양방치료

- ① 내과적 치료 : **P 투여**(=일명 생리주사)하여 비후된 자궁내막을 떨어뜨림
- ② 수술적 치료 : **소파(D&C)** : 부정출혈의 병소를 제거하는 의미와 진단적 가치도 있음.
 - [대상] 일반적으로, 자궁내막증식증이 심하거나, *나이가 있는 사람들은 D&C(소파)를 권함 *나이가 많은 환자의 경우, 비정형성 내막의 전암 가능성을 항상 두어야함.
 - [장점] 자궁내막을 긁어내면, 부정출혈을 일으키던 병소를 제거할 수 있음. 또한, 암 진단을 위한 조직검사에 필요한 자궁내막을 훨씬 많이 얻을 수 있음.
(암의 최종검사=조직검사)
 - [단점] 자궁내막에 상처가 많아짐. 소파 이후 출혈이 잘 멈추지 않는 경우도 종종 있음

※ 소파 = 자궁긁어냄술 = D&C(dilatation and curettage)

- 자궁경부를 기구로 긁어내는 수술로 시료를 확보함으로써 자궁내막증식증을 확인

*한방

- [장점] 자궁내막증식증은 떨어져 나가야 하는 자궁내막이 떨어지지 않는 **완전어혈** 상태. 격하/혈부축어탕 등 **파어소종** 시키는 약을 사용하여 월경주기의 회복을 목표로 함.
- [단점] 언제 출혈이 나타날지 알 수 없다는 단점(예측할 수 없음)

※AMH: 예후 평가 인자, 높을수록 예후가 안 좋음.

3절 월경부조 p.42

1. 개술

- ① 동의보감: 월경이 앞당겨지거나 늦어지는 것과, 월경량이 많아지거나 적어지는 것
- ② 분류: 월경선/후기, 월경선후무정기, 월경과다, 월경과소, 경기연장, 경간기출혈, 봉루
- ③ 병인: 정신적/심리적 불안정, 과로, 지나친 성생활로 충임맥의 기능이 유지되지 못한 경우, 외감/내상, *약물 등 → 모두 영혈을 상하게 하여 월경부조를 유발

*환자들의 약물력을 조사하는 것은 기본 중의 기본.

④ 임상적 의의

- 임상에서 월경이 앞당겨지거나 늦게 오더라도 '규칙적'이지만 하다면 월경부조를 주소로 오는 환자는 없음.
- 월경부조는 한열허실 등 변증의 단초를 제공하는 근간이 됨.

★월경부조의 주기, 양을 한, 열, 허, 기체혈어로 구분하는 대강을 쓰시오 '11,12,14,18

<양상>

	期	量	色	質
열	선기(先期) 주기 빨라짐	多	심홍(深紅)	조稠(끈끈)
한	후기(後期) 주기 늦어짐	少	암(暗)	혹괴(或塊)
허	경기연장 (經期延長)	多	담홍(淡紅)	희(稀) 묽음
	경간기출혈 (經間期出血)			
기체	선후무정기 (先後無定期)	或多 或少 많았다 적었다 한다	자홍(紫紅)	혹괴(或塊)
혈어	-	정상 或少	암자(黯紫)	혈괴(血塊)

- ① 열증이면 ⇒ 월경은 대개 빨리오고, 양도 많아지고, 색은 심홍한 편이고, 질은 더 끈적해짐
- ② 한증은 기능저하를 의미하므로 ⇒ 월경은 대개 느려지고, 양도 적고, 색은 어둡고, 한응하면 간혹 혈괴가 있을 수 있음
- ③ 허하면 대맥이 무력해져서 허리춤에서 꼭 잡아주는 힘 약해지므로 ⇒ 월경 기간이 길어지거나, 경간기 출혈이 발생, 월경량 많아지고, 색은 담홍하고, 질은 희박해짐
- ④ 기체는 ⇒ 선후무정기하고, 월경량도 불규칙하고(많았다 적었다), 색은 자홍(하거나 정상), 간혹 혈괴가 있을 수 있음
- ⑤ 혈어하면 ⇒ 일반적으로는 월경량은 적어지나 정상인 경우도 있으며, 색이 가장 어둡고, 반드시 혈괴가 생김

[참고]

- ✓ 혈괴는 패드에 묻은 덩어리가 아니라, 핏덩어리가 울퉁하고 나가는 느낌을 물어보아야 함
- ✓ 월경색과 질(質)의 문진이 가장 어려움. 환자 본인도 남과 비교를 해본 적이 없어서 구분이 잘 안되는 경우가 많음.

4절 월경선기 p.43

1. 개술

1) 정의

- 월경간격이 연속 2주기 이상 21일 미만인 경우
(난임이 문제일 때는 21일이 아니라 24일 기준으로 봄 - 10주차의 FIGO 분류 참고)
- 經早, 月經前期, 經水先期, 經水一月再行라고도 함 (한달이 안되었는데 또 나온다)

2) 원인

① 내분비 요인

- 시상하부(HPO축) 조절 이상 → 무배란, 난포기 혹은 황체기 단축의 결과로 초래됨
황체기 단축은 드문 편 (일단 배란이 일어나면 14일 뒤에 무조건 출혈이 발생하기 때문)
따라서 대부분 난포기 이상에 해당.
- 초경 직후 / 폐경기 전후 빈발
- 20~40대 심한 육체적 또는 정신적 스트레스에 의함

② 전신적 요인

- 갑상선기능저하증 항진증에서 오히려 더 많이 오는 경향도 있음.
- 만성 골반염증성질환
약간의 미열을 일으키기 때문에 월경선기로 구분하였지만 실제 만성골반염증성질환에서 월경선기가 문제가 되는 경우는 실제로 거의 없음.

+) 월경선기는 대개 배란부전(따라서 난임과 임상적 관련성 ↑)이며, 배란주기 문제일 때도 있으나 이때는 배란 전기가 짧아지는 것이 대부분이며 배란 후기가 단축되는 일은 극히 드뭄 → 난포기의 문제이지, 황체기의 문제가 아님!

2. 병인병기

- 기허 : 비기허약, 신기불고
- 혈열 : 양성혈열, 간울혈열, 음허혈열
- 그 외 : 혈어조체

3. 변증치료 ★★★

[대원칙] 월경선기이므로 기본적으로 “월경의 주기가 빨라짐”을 갖고 있음. 맥진은 안중요하다고 말씀하셨었음.

변증	임상증상	치법 (언급X)	처방
★★★ 비기허약 '05,11, 13,17	- 월경주기가 당겨지면서 양이 일정X & 많은 편, 월경 담홍색, 질은 희박 - 피로를 많이 호소하며 자주 누워있고, 숨이 차고 목소리에 힘이 없다. - 간혹 가슴 및 복부에 더부룩한 불편감을 많이 느끼며, 식욕이 떨어지고, 대변이 무르다. 얼굴이 창백하거나 누렇게 됨. - 설담홍 태박맥 맥허완무력	보비익기 섭혈고충	¹ 보중익기탕, 귀비탕 ² 거원전, 익위승양탕 ³ 수비전
신기불고	- 월경주기가 7일 이상 빨라지고 월경량이 일정하지 않으나 다소 많은 경향, 월경색이 연하면서 질이 희박 - 정신력이 떨어지며, 허리와 무릎이 시큰거리며(요슬산연), 힘이 없어지고(소력), 손발이 차며, 소변이 맑고 양이 많으며 야간에 소변을 자주 본다. - 설미암 태박맥 맥침세	보신익기 고충조경	귀신환 ⁴ 온충탕
양성 ⁵ 혈열 '17	★★월경부조에 활용는 선기탕과 과기음의 적응증을 쓰시오 '04,11 - 월경주기가 당겨지고 월경량은 많으며 월경은 심홍색/자홍색이고 질은 끈적(조점), 덩어리O - 열병 증상: 얼굴과 입술이 붉으며 입이 마르고, 가슴이 답답하며, 변비가 있고 소변이 붉게 나온다 - 설홍, 태황, 맥활삭/홍활	청열사화 량혈조경	청경산, ⁶ 청화음 금련사물탕 ★ ⁷ 선기탕'04, 11 (적응증)
간울혈열	- 월경주기가 당겨지고 월경량은 일정하지 않은 경향(=기체)이 있고 월경 자홍색이고 질은 점조하고 혈괴가 있기도 함 - Stress 연관, 머리와 눈이 어지럽고, 가슴과 옆구리가 더부룩하며, 아랫배가 더부룩하면서 아프고(소복창통), 우울하고, 유방이 아프며(유방창통), 가슴이 번조롭고 성을 잘 내며, 입이 쓰고 인후가 건조하고 탄식을 잘하는 등의 증상이 수반 - 설암홍 태황 맥현활삭	소간해울 청열조경	단치소요산 ⁸ 청경사물탕 화간전 청간달울탕
★★ 음허혈열 '05,13,17	- 월경주기가 당겨지며, (음허이므로) 월경량이 적고 월경색은 홍색 질은 점조 - 몸이 마르며 피부가 건조하고 머리와 눈이 어지럽고 가슴이 번조롭고 인후가 건조하며 손과 발바닥에 열이 난다. 간혹 광대뼈가 붉고 조열이 수반되기도 한다. - 설건홍 태소 맥세삭	자음청열 조경	⁹ 양지탕 생지황산 ¹⁰ 지골피음
혈어	- 월경주기가 당겨지고 월경량이 많고 덩어리지거나 월경량이 적으면서 점상 출혈을 보이며 월경색은 검다 - 혈괴 있으면 하복부 동통 → 혈괴 배출 시 통증 완화, 얼굴색이 어둡고 피하에 어반이 있는 경우도 있음 - 설암홍 반점 혹은 어반 맥삽 혹은 맥침현	활혈화어 조경	¹¹ 도홍사물탕(기본방) ¹² 통어전 ¹³ 강금사물탕

- ① 비기허약의 기본방: 보중익기탕, 귀비탕
- ② 거원전, 익위승양탕: 보중익기탕의 변방
- ③ 수비전: 귀비탕의 변방 : 귀비탕 去 용안육 백복신 加 산약 연자육 건강
 - 다른 이름은 섭영(攝營)전 = 수삼 기능(거뒀다는 작용) 강화하여 비통혈 기능 강화한 의미
- ④ 온충탕: **보약들과 자석영을 포함**
 - 교수님은 광물성 약물 안 좋아해서 한 번도 안 써봄. 자석영도 불소가 많이 함유되어 있어 신경에 작용하면 따뜻하게 하는 작용이 있다고 하나 안써봐서 모르겠다고 하심.
- ⑤ 혈열증: 금련사물탕 & 선기탕에서 모두 숙지황 대신 생지황
- ⑥ 청화음: 작약, 맥문동, 생지황 등 자음시키는 약물이 많음. 청화음은 원래 음허혈열에 더욱 활용되는 처방이라고 생각하심
- ⑦ **선기탕(先期湯): 월경 선기 - 양성혈열에 사용**
 - 구성 (12가지): 사물탕(숙지황 대신 생지황, 당귀, 백작약, 천궁), 향부자(조경의 기본) + 삼황(황금 황련 황백) + 지모(찬약:열을 꺼줌) + 아교(끈끈해서 재출혈 방지), *애엽 + 감초
 - *애엽은 좌훈(한약재를 끓여서 나오는 증기를 회음부에 쬌는 한방요법)할 때 다용하며, 본래 수삼시키는 작용이 강한데 태우면 그 작용이 더욱 강해짐. 온성이며, 그 자체로도 지혈작용O
- ⑧ 청경사물탕: 선기탕과 구성은 같으나 용량 차이
 - 선기탕은 생지황 당귀 백작약이 균약임.
 - 당귀를 균약으로 하고 생지황을 신약으로 밀어놓은 것이 청경사물탕
- ⑨ 양지탕: 생지황과 지골피의 '지'를 따서 지어진 이름
 - 갱년기 상열감에 생지황 지골피는 빠지는 법이 없음
 - 지골피: 폐결핵같은 음허열증에 사용하는 약 (본래 구기자는 보음지제 인데, 지골피는 보음 작용이 별로 없고 주로 간/폐/신경에 들어가서 간열/폐열/골증조열을 내려줌.)
- ⑩ 지골피음: 사물탕에서 숙지황 대신 생지황 / 加 목단피 지골피
- ⑪ 도홍사물탕: (언급X) 당귀를 당귀미로 바꾸면 약력이 더욱 강해짐
- ⑫ 통어전: 산사육을 대제로 쓰면 활혈거어지제로 바뀜. 위에 어혈이 있을 때 산사를 더 중하게 씀.
- ⑬ 강금사물탕: 사물탕 + 향부자, *강황, 황금, 목단피 현호색(통증 타겟 약재)
 - *강황은 온성이지만 부인과에서 많이 쓰지는 않으며, 풍습비통의 요약이라 재활과에서 다용
 - 부인과에서는 잘 안쓰고 오십견 등에 사용 (울금 역시 부인과적으로는 잘 안쓰임)

혈괴란 무엇인가?

※ 월경의 생리

- ① 정상 월경 = 순수혈액만 나옴.
 - 자궁내막의 간질, 미세혈관 등이 액화효소의 작용에 의해 월경혈(순수액체)로 나오는 것
 - ② 월경을 멈추게 하는 인자 : 항응고인자, E
- 월경 초기에는 원활한 배출을 위해 와파린과 같은 액화효소가 분비되어 순수한 혈액(액체) 형태로 배출됨. 따라서 월경혈에는 덩어리가 없는 것이 정상
→ 혈괴가 생긴다는 것은 병리적인 현상을 시사함.

※ 혈괴의 병리

- 혈괴 = 패드에 덩어리가 묻는 경우
- ① 액화 효소가 충분히 분비되지 않거나 작용할 시간이 없는 경우
 - 월경량이 너무 많아서 액화 효소가 작용하기도 전에 덩어리가 그대로 배출되는 경우가 대부분
 - 예 자궁선근증에서 울컥울컥 핏덩어리가 나오는 것
 - 경기연장 환자는 액화효소 작용할 시간이 있으므로 혈괴가 드뭄
- ② 자궁내막의 순환이 원활하지 않아 충임/혈실에 어혈이 있는 경우 (드뭄)
- ③ 정서/컨디션 등의 이유로 자궁내막이 일정하지 않게 자라는 경우
 - 많이 자란 쪽에서는 떨어뜨려야 될 것이 많다고 인식하여 수축력이 상승함 → 월경통 유발
 - 예 출혈량이 많지 않은데, 덩어리(혈괴)가 있고 월경통이 심한 경우

※ 임상

- 임상에서 제일 많이 듣는 말 = ‘커피 색 월경’ + “커피찌꺼기 같은게 섞여있다”
→ **출혈량이 적은 경우에 多** (월경량이 적어 자기제한적 특징에 의해 피를 저장했다가 한번에 내보내는 것이 소량씩, 점진적으로 진행됨. 즉, 출혈이 자궁 상부에 오래 머물러 갈변한 것)
- 이런 경우, 대부분 월경량이 적어서 밀어내는 힘도 약해지고 빨리 빨리 떨어지지 않음.
- 색만으로 굳이 치료하지 않고 주기의 이상이 있는지 확인

5절 월경후기 *p.51*

1. 개술

1) 정의

- 월경 주기 40일 이상 연장되는 것
- 무월경 되는 경우가 많아 자세한 검사와 지속적인 관찰 필요
- 經遲 月經落後 經水後期 經行後期라고도 함.

2) 원인

- 내분비 요인 / 전신적 요인
- 과도한 육체적 정신적 스트레스
- PCOS, 지속적 황체 (Halban's disease) 등
- 폐경기를 전후하여 월경 주기가 늦어질 수 있음

2. 병인 병기

- 허, 한, 어, 담음의 병기로 나누어짐.
- 허증: 기혈허약, 혈한
- 실증: 담습, 기체혈어

3. 변증치료 ★

변증	임상증상	치법	처방
기혈허약 '17	- 월경주기가 늦어지고 월경량↓, 월경색이 연함, 월경 시 아랫배에 은근+지속되는 통증(이건 없을수도) - 얼굴색은 창백하거나 누렇게 몸이 피곤하며 기운이 없고 식사량도 적다. 머리가 어지럽고 눈이 어질어질하다. 가슴이 뛰고 잠이 오지 않는다 - 설담홍, 태백, 맥세약	보기양혈조경	소영전 인삼양영탕
★★★★ 혈한 '05,11, 13,17	- 월경주기가 늦어지고 월경량↓, 월경색은 黯색, 덩어리O, 월경 시 요복(허리배)이 차면서 통증 - 사지가 차고 허리와 무릎이 차면서 통증이 있다. 얼굴이 창백하고 변이 무르며 소변이 맑고 많이 나온다. - 설담암, 태백, 맥침지	온경산한 통체조경	¹ 온경탕 ² 당귀사역탕 우귀음
담습	- 월경주기가 늦어지며 월경량이 일정하지X, 월경혈에 점액이 섞여 있을 수 O, 연한 월경색 - 월경전후에 뭉거나 점액성의 대하가 있는 경우가 많음 - 비만한 체형, 어지럽고 가슴 뛰며 가슴 밑이 갑갑하면서 매스껌고 가래침 같은 분비물(담연)을 토하기도 함 - 설반(胖)하고 치흔이 있기도 하며, 태백니, 맥활리	건비화담 이수조경	이진탕+천궁, 당귀 육군자탕+귀궁탕 도담탕 창부도담탕
기체혈어 '17	★★월경부조에 활용은 선기탕과 과기음의 적응증을 쓰시오 '04,11 - 월경주기가 늦어지며 월경량은 적거나 정상, 월경색 자암, 덩어리O, 혈괴가 배출되면 (고정불리통) 통증완화 - 피부는 윤택하지 못하고 설자암하고 어반이 있으며, 맥현/침	활혈화어 조경지통	★ ³ 과기음'04,11 ⁴ 소간해울탕

★금궤요락과 교주부인양방의 온경탕의 변증 요점을 쓰시오. '19

① 온경탕 (여기 나온 온경탕은 부인대전량방의 온경탕)

- 온경탕은 한 대-청대 10종, 청대 이후에 11종으로 총 21종이 있음.
- 최초의 온경탕은 금궤요락에서 등장함.

금궤요락의 온경탕: 군약이 **오수유**로 당귀, 인삼, 백작약, 천궁 등이 들어감.

→ '**허한**'형에 응용하는 것이 목적

BUT 우리가 일반적으로 사용하는 온경탕은 방약합편에 나오며 군약은 **맥문동 (자음 중시)**

부인대전량방의 온경탕: 오수유는 안 들어가고 계심과 봉출, 우슬이 들어감 → '**실한**'형에 응용, 월경이 안나오는 상황에서 월경을 파기시키는 작용도 있음.

- PCOS에 온경탕 활용 多 → 한증의 정도에 따라 오수유 용량 조절 (오수유는 난소 기능 UP)

② 당귀사역탕

- 월음병에 수족결한, 맥세육절할 때 온경통락 시키는 당귀사역탕 사용 (계지 포함)
: 표증 → 수족결한(혈허한결): 혈허한 사람이 한사에 감촉되어 자각증상이 강함
→ 스스로 차갑다고 느낌
- [비교] 사역탕: 소음병에 양기가 내허하여 수족결냉, 맥미세, 단육매할 때 사역탕(부자 포함)
: 리증 → 수족결냉: 타각증상이 강함; 남이 만졌을 때 매우 차가움

③ 과기음

- 구성 : 사물탕+향부자(조경의 기본) + 도인, 홍화, 봉출, 목통(부수어서 내려보냄) + 육계(온경 시켜 활혈거여 도움) + 감초, 목향을 가미
- ★ [주의] '선기'탕이 '혈열'에 쓰인다고 '과기'음이 '혈한'에 쓰일 것이라 넘겨짚지 말 것
선기탕은 월경선기-양성혈열 / 과기음은 월경후기-기체혈어

- ④ 소간해울탕 : 화제국방의 소간해울탕이 아니라, 증의부과(증의학)의 소간해울탕

6절 월경선후무정기 p.55

↑ 변증치료-증상&처방 외에는 거의 언급X

1. 개술

- 정의 : 월경이 주기적이지 않고 7일 이상 앞당겨지거나 늦어지는 것
- 월경선후무정기의 한의학적 표현: 一月 二至 二月 一至

- 경란, 경행혹전혹후, 경수선후무정기, 경행선후무정기 라고도 함.
- 출혈양상 : 반상출혈(spotting), 하혈, 1회의 단기간 출혈 등 출혈량과 기간은 다양
- 국소질환에 의한 경우 多 (자궁내막암 자궁경부미란, polyp, 배란기출혈, 경구피임제나 Estrogen과용 오용, IUD)

2. 병인 병기

- 간비신의 기능 손상으로 발생 (가장 많이 볼 수 있는 형태는 간울)

※보통 월경선후무정기 자체로 내원하는 것이 아니라 PCOS, 봉루 등 다른 병리에 동반될 때 내원함. 따라서 단순한 구분이 아니라 어떤 질환이 초가 되는지를 확인하여 치료계획을 세워야 함.

★월경선후무정기의 변증 형태를 쓰시오.. '19

3. 변증치료 ★

변증	임상증상	치법 (언급X)	처방
신허 '17	- 초경직후 신기가 미성숙하거나 폐경때쯤 신기가 다 하려고 할 때 많이 보이는 형태 - 월경이 선후로 불규칙하고 월경량 ↓ - 색은 연하면서 어둡고(암담색), 질은 묽다 - 허리와 무릎이 시리며 사지가 참 - 소변이 맑고 많으며, 야뇨가 빈번함 - 간혹 머리가 어지럽고, 귀가 울리며, 요천부가 아픔 - 설담, 태백, 맥침세약	보신조경	고음전 보음익 신탕 귀신환 우귀음 좌귀환
간울 '17	- 가장 흔한 형태로, 월경주기&월경량 모두 불규칙 - 월경색은 정상이거나 붉은 자주색 - 월경에 혈괴가 있는 경우도 있음 - 흥협/유방/소복창통, - 정서적 긴장이 심함, 속이 답답하고 성을 잘 냄 - 트림이 잘 나고 음식을 적게 먹으며 탄식을 잘함. - 설은 정상이거나 홍, 태박백/박황, 맥침현	소간해울 화혈조경	소요산 ¹ 일관전 시호역간산 ² 정경탕
비기 허약	- 월경주기 불규칙, 월경색은 연하고 질이 묽음 - 피곤하고 기력이 없으며 나른하고 눕는 것을 좋아함. - 숨이 차고 말에 기운이 없으며, 두근거리고 잠을 잘 자지 못함(심계실면). 식욕부진, 연변 등의 증상 - 설담, 태백, 맥완무력	건비강위 보기조경	팔물탕 궁귀사 군자탕 삼령백 출산

¹일관전: 간신음허 간기불서로 흥협창통 소복산기에 쓰는 약, 산기(産氣) 때문에 사삼이 군약, 기체를 해소하기 위해 천련자가 들어감.

²정경탕 임상 활용도 높음

7절 월경과소 p.60

1. 개술

- 정의 : 월경주기가 규칙적이나 출혈량이 감소 (35세 이후는 생리적 감소)
- 대체로 월경과소 자체는 **치료 대상이 아님**.
- 실제 치료해야하는 경우는 출혈량이 30ml 이하인 경우임.
→ 특히 임신이 문제가 될 때에 한하여 치료
- 경수체삽, 월경과소, 경소, 경후미소, 경행미소 라고도 함.
- 원인: 국소요인 내분비요인 전신적요인 + 자궁 내강의 과도한 소파, 심한 자궁내막염 후에 오는 자궁 내막의 유착 (Asherman's syn), 골반결핵 등

2. 변증치료

변증	임상증상 (언급X)	치법 (언급X)	처방
신허	- 평소 월경량 적거나 차츰 감소 - 월경색은 옅고 질은 묽음 - 요천부가 시큰거리고 시리며 아랫배가 차고 야간에 소변이 잦음 - 외음의 발육이 지연되고 자궁의 크기가 작거나 초경이 늦어지기도 함 - 설담홍, 태박백, 맥침세	보신익정 양혈조경	¹ 당귀지황음귀신환좌귀음
혈허	- 월경량↓ 간혹 정상량에서 차츰 줄어들기도 하고, 어떤 경우는 조금씩 문어나오다 멎어버림 - 월경색 연한 붉은색, 질은 묽으며, 덩어리는 없음 - 월경할 때 아랫배가 은은하게 아프고, 안색이 누렇게 거칠며, 어지럽고 눈앞이 어지러움 - 가슴이 두근거리며 숨이 빨라지고, 입술과 손톱이 희며 윤택이 없음 - 설담, 태박백, 맥세약	보기양혈 조경	² 자혈탕 소영전
혈어	- 월경량 적고, 배출이 원활하지 못함 - 월경은 어두운 붉은색이며 덩어리 있음 - 가슴과 옆구리가 더부룩하고 답답하며 결리고, 아랫배가 아픔 - 설자암, 어반이 있고, 맥침현삽	이기화어 활혈조경	³ 소요산+사물탕 ⁴ 시호소간산
담습 조체	- 월경량 적고, 점액이 섞여있음. - 월경색은 연하고 질은 점성이 있거나 묽음 - 몸이 비만하며 힘이 없고 권태로움 - 가슴이 답답하고 팔다리에 붓기가 있음 - 설반(胖)하고, 치흔이 있으며, 태백활/백니, 맥현활	건비화담 양혈조경	이진가궁귀탕 단계담습방

① 당귀지황음(경약전서): 육미 去 산사 加 당귀 두충 우슬 감초

② 자혈탕: 팔물탕과 비슷. 인삼 향기 산약 복령 등을 포함.

③ 소요산: 백출, 백복령, 건강 포함하여 간을 →간기회역 한 것을 소간해울 + 건비회습 작용

④ 시호소간산: 백출 백복령 건강 X / 간울로 꼭 막힌 상태: 항부자 진피 지각으로 이기작용 UP

8절 월경과다 p.64

1. 개술

- 정의: 월경과다는 월경주기는 규칙적이나 월경량이 많은 것
- 증상: 출혈기간이 8일 이상, 출혈량이 80ml 이상으로 증가
- 원인

★ 월경과다나 경기연장에 대해 암을 제외한 여성 생식기의 기질적인 원인에 대해 쓰고 그 이유를 기술하시오 '11

① 자궁내막폴립	실제 임상에서는 경기연장(월경지연)과 더욱 관련있음 폴립으로 자궁 내 구조적 안정성이 망가져 지혈 방해 → 자궁내막의 표면적 증가로 월경량 증가
② 자궁내막증식증	- E파탄성 출혈 양상: 일정 기간 무월경이었다가 갑자기 폭발적으로 나오는 과량의 출혈 혹은 한달 내내 나오는 월경 - 자궁내막의 표면적 증가로 월경량 증가, 자궁내막암과 연결될 가능성 多 - 처음엔 월경과다지만 나중엔 유착하는 부분이 생겨 월경과소, 무월경으로 이행
③ 자궁선근증	- 가장 많음. 분비선의 문제로 월경과다와 함께 극심한 월경통이 문제가 됨
④ 난관염	- 골반염증성질환의 주 포커스가 됨 - 골반염의 총혈로 월경과다가 발생할 순 있지만 흔하진 않음
⑤ 자궁내막염	- 자궁내막은 피를 담아뒀다가 쏟아내 균이 서식하기에 어려운 환경이라 자궁내막염은 거의 없으나, 염증 생기면 골반염증으로 발전가능 - 이때 골반염의 총혈로 월경과다 발생할 순 있지만 흔하진 X
⑥ 자궁내피임장치	- 프로게스테론의 영향이 지속될 때 월경량이 적게, 오랜 기간동안 지속될 수 있음
⑦ 자궁근종	- 점막하 근종: 부정출혈/경기연장을 유발 - 근층내 근종: 경기연장(대부분), 월경과다

+) 무배란성주기, 부정박리 (②③⑦이 가장 흔한 3가지)

④난관염 & ⑤자궁내막염은 월경과다가 문제가 아니라, 염증으로 인한 통증이 문제!

2. 병인 병기

- 기허, 실열, 허열, 어혈

3. 변증치료 ★

변증	임상증상	치법	처방
기허	- 월경량 ↑, 색은 연한 붉은색/정상, 질은 묽음 - 얼굴창백, 힘이 없고, 아랫배 은은통 - 설담, 태백박, 맥세약	보기섭혈	거원전 수비전 익위승양탕
★★ 실열 '05,11, 13,17	- 월경량 아주 많고, 색은 선명하게 붉거나 어두운 <u>붉은색, 질은 끈적하고 광택이 있음.</u> - 입이 마르고 속이 답답하고, 몸에 열이 있고, 얼 굴이 붉고 대변이 굳으며, 소변은 노란색이거나 붉고, 작열감이 있음 - 설홍강, 태황, 맥삭	청열량혈 지혈조경	약영전 서울청간음 ¹ 해독사물탕 ² 가감석홍전
허열	- 월경량 많고, 질은 붉은색, 질은 걸쭉함 - 간혹 주기가 당겨지거나 8~9일이 되어야 비로 소 멎음 - 도한이 있고, 입안과 인후가 마름 - 간혹 어지럽고 귀가 울리거나 가슴이 갑갑하고 열감이 있어 잠을 잘 못자고, 양관(顴, 광대뼈) 가 붉고 조열이 동반됨 - 설홍, 태소/무태, 맥세삭	자음청열 고충조경	³ 가감일음전 보음전
혈어	- 월경량이 많고, 색은 검은 자색, 덩어리가 있음 - 아랫배가 아프고, 복부를 누르면 거부반응 - 월경혈의 덩어리가 배출된 뒤에는 동통이 경감 됨 - 뚜렷한 증후가 없을 수도 있음, 간혹 허리가 시 리거나 피부에 윤택이 없을 수 있음 - 설자암하고 어점/어반이 있을 수 있음, 맥침삼/ 침현	활혈화어 고충조경	⁴ 실소산 ⁵ 단삼택란음 소복죽어탕

① 해독사물탕: 사물탕 + 황련해독탕 (사물탕 숙지황대신 생지황)

② 가감석홍전: 차가운 약재인 지유를 초흑하여 군약으로 넣음. 초흑하면 찬 성질이 많이 사라지므로 가감석홍전은 하부출혈에 두루 사용할 수 있는 범용 처방임.

※자궁선근증은 자궁 내 병변이 있되, 난소 기능은 정상이라 배란을 동반한 출혈이 과다한 상태임. 즉, 부정 출혈이 아닌 월경을 하되, 월경량이 많은 것이므로 '색류'로 보는 것은 적절치 않음.

★ 부인과 질환의 음허혈열에 사용하는 보음전과 가감일음전의 변증 요점 차이를 쓰시오. '19

③ 보음전 vs 가감일음전: 둘 다 음허, 혈열에 사용 → 자음, 청열의 효능 0

- 가감일음전: 자음이 강함 (생지황 지골피로 퇴허열) → 음허가 중한 경우

- 보음전: 황금 황백 넣어서 청열작용 강함 → 열증이 중한 경우

④ 실소산: 포황+오령지, (아랫배에서 통증이 시작되어 상충하는 증상에 사용)

⑤ 단삼택란음 → 산과에서 중요한 약으로 본래 산후 오로 과다에 다용

(택란: 治수의 요약인 택사와 비슷한데, 택란은 치수 + 行瘀작용, 산후 초기에 다용)

9절 경기연장 p.69

1. 개술

- 월경주기는 기본적으로 정상이면서 월경의 지속시간은 7일 이상인 것
- 월경과다의 한 유형
- “월수부단 월수부절 경사연장”

2. 변증치료

▷ ‘우측 표랑 보세요’

- ① 오적골: 수렴작용
- ② 우여량: 토복령이 아니라 광물성 약물을 말함. 교수님은 선호하지 않으심.
지혈+지해+지삽 작용
cf. ‘토복령’의 이명이 ‘우여량’이기 때문에 혼동 주의 (토복령은 리습해독 작용)
- ③ 건고탕: 경전설수(월경전 설사)에 이용
- ④ 패장초: 부인과적으로 유명한 약, 패장은 장이 썩었다는 의미로 장이 썩은 냄새가 나는 풀이라는 의미로 당귀, 천궁 등과 섞어서 사용함.
활혈거어 + 소종배농 작용이 있어 골반 염증성 질환(PID)에 가장 많이 응용되며 징하, 자궁근종에 응용 (생각보다 냄새 심하지 않아서 환자 거부감이 그렇게까지 심하지 않는데 차가운 약이라 배가 냉한 사람은 주의할 것)
- ⑤ 인동등: 질염 등에 외용제로도 많이 응용함. 인동덩굴의 꽃은 금은화, 줄기는 인동등으로 청열양혈 작용 & 조습시키는 작용이 있음.

변증	임상증상	치법 (언급X)	처방
기허	- 가장 많은 형태 - 매월 월경기간이 7일 이상 - 월경색 <u>담, 질청희</u> - 피곤무력한데 활동시에는 두훈안화, 다한, 복만식소	보기고충 지혈조경	① 귀비탕 + ¹ 오적골 종려탄 ② 거원전 +애엽 건강 오적골
비신양허	- 월경기간이 7일 이상으로 연장 - 복만냉통, 신피체권 기단라언 식욕부진	건비보신 조경지혈	① ² 우여량환 ② ³ 건고탕 +보골지, 오적골
음허내열	- 월경기간이 7일 이상으로 연장 - 월경량이 많지X, <u>선홍/암홍색</u> - <u>질건조</u> , 몸이 마름 - 관홍, 조열심번, 인건구조	자음청열 조경지혈	① 고경환 + 생지황 한련초 ② 보음전
습열온결	- 월경이 <u>淋漓</u> 하고 <u>그치지X</u> - 패장(썩은 장)같은 색 - 월경혈에 점액이 섞여있고 예취O - 신열이 오르내림, 요복창통, 피핍라언 - 평소 대하량이 많은데 색황취예	청열이습 지혈조경	① 사묘산 + ⁴ 패장초 지유 인진 ⁵ 인동등 ② 대분청음 + 오적골
기체혈어	- 월경기간 연장 - 색이 <u>암하고 괴가 있다</u> - <u>소복통</u> , <u>거안</u> , <u>면색어둡</u> - 순설 자암 어반O	활혈화어 지혈조경	도홍사물탕

10절 경간기출혈 p.73

1. 개술

- ※ 보통 경간기출혈에 크게 의미를 부여하지 않음. (중요하지 않다고 말씀하심.)
- 에스트로겐의 수치에 민감한 자궁내막의 상태 출혈
 - 규칙적인 월경 주기와 주기 사이에 오는 것으로 대개 양 많지 않은 출혈
 - *음양전화의 과정의 이상으로 보아서 보음을 기본으로 하면서 겸증을 고려한 치료
 - 음양전화 : 음장과 양장이 상호전화하여 월경주기가 지속되는 것

※ 음장 & 양장

- ① 陰長の 시기: 난포기(월경~배란 : 자궁내막 증식기) / 자음역향탕 사용
(抑抗 : 항체 반응을 억누른다는 뜻에서 억항이라고 함.)
- ② 陽長の 시기: 황체기 (배란 ~ 월경) / 조양역향탕 응용
- 음장의 시기가 끝나고 양장의 시기가 와야하는데, 이런 것에 균형이 깨져서 경간기 출혈이 나타난다고 보는 관점.

2. 변증치료

▷ 표 설명 아래 내용 대충 설명하고 넘어가심.

- ① 이지환: 여정자+한련초로 구성 / 여정자는 순수하게 자음시키는 약물 / 한련초는 간, 심포경으로 가는 약물이며 양음+양혈+지혈작용이 있어 초탄하지 않고 사용함. 특히 상행하는 성향이 있어 열성 고혈압과 열성 코피 등에 다용함.
- ② 육린주: 방약합편에 나오는 '조경종옥탕', '부익지향환'과 함께 **불임 처방 3총사**에 해당. 육린주는 기혈양허 중 양허에 더 치우쳐있는 경우 응용하며, 구성은 팔물탕에 토사자 녹각 두충 천초 등 보하는 약을 더함.
- ③ 청간지림탕: 본래 오색대하 중 적대하 처방이나, 요즘은 오색대하 이론을 사용하지 않음. 대하색을 청적황백흑의 5가지 오행으로 나눈 이론으로, 억지 이론이라고 생각하심.
- ④ 팔정산: 빈용처방으로, 본래는 방광염, 요도염, 피뇨 등 소변 문제에 응용하였음. 주로 리소변시키는 약물들로 구성됨.
- ⑤ 북방홍등전: 중의학에서 PID(골반염증성 질환 = 분강염盆腔炎)의 1호방으로 사용. 원래 홍등이 들어가는데, 우리나라에는 홍등이 없기 때문에 다른 약물로 대체하여 쓰기도 함. 단, 약성이 홍등과 동일하지 않으므로 한계가 있음. (홍등은 계혈등이 아님)

거의 변증명과 처방 설명 간단히만 하고 넘어가심.

변증	임상증상	치법 (언급X)	처방
음허양성	- 경간기에 소량의 선홍색 출혈, - 질이 끈적끈적하며 덩어리는 없음 - 뚜렷한 증상이 없거나, 관홍조열, 인건구조 하거나 간혹 요퇴산연, 대변건결, 소변단황 - 설홍 태소 맥세삭	자음청열지혈	① 양지탕 ② ¹ 이지환 + 육미지향환 + 속단 토사자 녹각
신양편허	- 월경색이 옅은 붉은색이며 덩어리가 없음 - 두훈요산, 소복냉양, 신피핍력 - 빈뇨, 대변혹당 - 설담홍 태박백 맥세	자음조양 익기지혈	건고탕 우귀음 ² 육린주 (毓麟珠)
습열류체	- 경간기 출혈, 월경 중 질이 끈끈하면서 미끈하고 덩어리는 없음. - 간혹 적백대하가 있고 냄새가 나는 경우O - 전신이 무겁고 시큰거리며 신피핍력, 홍민번조, 식욕부진, 소변단적 등을 수반 - 평소에도 대하가 많고 질이 끈적하며, 간혹 아랫배가 창통하거나 냉감이 있음. - 설홍 태(황)백니 맥세유/현세	청열이습지혈	³ 청간지림탕 ⁴ 팔정산
혈어	- 경간기 출혈이 있으며, 월경색이 자흑하고 간혹 혈괴가 있음 - 월경기에 소복창통/자통, 홍민번조(가슴이 답답하고 속이 타서 불안정함) - 설질에 자점(紫點)이 있고 맥현세	화어지혈	축어지혈탕 ⁵ 북방홍등전